

MÓDULO 1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(SUS — Legislação e Políticas de Saúde)

Concurso Praia Grande 001/2026 · IBAM · Médico de Família e Comunidade
Baseado no Edital Oficial e Legislação Vigente — Atualizado mai/2026

SUMÁRIO

Nº	Tema	Pág.
1	CF/88 — Saúde como Direito Fundamental	3
2	Lei 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde	4
3	Lei 8.142/1990 — Participação e Controle Social	6
4	Decreto 7.508/2011 — Regulamentação da Lei 8.080	7
5	LC 141/2012 — Financiamento	8
6	PNAB 2017 — Política Nacional de Atenção Básica	9
7	Financiamento SUS — Emenda 29/2000, EC 86/2015, EC 95/2016	11
8	RAS — Redes de Atenção à Saúde	12
9	Promoção da Saúde — Ottawa e PNPS 2014	13
10	Determinantes Sociais da Saúde (DSS)	14
11	Territorialização e Diagnóstico Situacional	15
12	Vigilância em Saúde — Epidemiológica, Sanitária, Ambiental	16
13	LNDC — Lei Nº 13.979/2020 e Emergências	18
14	Sistemas de Informação em Saúde (SIS)	19
15	Planejamento em Saúde — PNS, PMS, PPA	20
16	HumanizaSUS — PNH 2004	21
17	Políticas Específicas (PNSI, PNSM, PNCD, PNCT)	22
18	PNI — Programa Nacional de Imunizações	23
19	Macetes e Pegadinhas	25
20	Questões de Revisão	30
21	Checklist Final de Revisão	38
22	Complemento — Gestão e Auditoria	39

1. CF/88 — SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Art. 196 a 200 — Seção II da CF/88

Artigo	Dispositivo	Conteúdo Principal
Art. 196	Direito à Saúde	Saúde é direito de todos e dever do Estado; acesso universal e igualitário; promoção, proteção e recuperação
Art. 197	Relevância Pública	Ações e serviços de saúde são de relevância pública; regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público
Art. 198	SUS	Sistema único com rede regionalizada e hierarquizada; descentralização; atendimento integral; participação da comunidade
Art. 199	Setor Privado	Participação livre da iniciativa privada; vedada destinação de recursos públicos para auxílio a entidades lucrativas
Art. 200	Competências do SUS	Controle e fiscalização; vigilância nutricional; formulação da política farmacêutica; ordenar a formação de RH; fiscalizar e inspecionar alimentos; colaborar na proteção do meio ambiente

■ **Macete — Art. 198 CF/88: Três Diretrizes**

- Descentralização (com direção única em cada esfera)
- Atendimento integral (com prioridade para atividades preventivas)
- Participação da comunidade

■ **Pegadinha — Setor Privado (Art. 199)**

- A participação da iniciativa privada é LIVRE (complementar, não exclusiva)
- VEDADO: destinar recursos públicos para auxiliar entidades lucrativas
- Contratos e convênios são preferencialmente com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos

2. LEI 8.080/1990 — LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

Tema	Artigos	Conteúdo
Objeto	Art. 1-2	Regula as ações e serviços de saúde; saúde como direito fundamental do ser humano
Fatores Determinantes	Art. 3	Alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer; acrescentado pela Lei 12.864/2013: atividade física
Objetivos do SUS	Art. 5	Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes; formulação de política de saúde; assistência às pessoas
Atribuições do SUS	Art. 6	Vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; saúde do trabalhador; assistência terapêutica; fiscalização de alimentos; formulação da política do medicamento; ordenação da formação de RH
Princípios	Art. 7	Universalidade, integralidade, equidade; descentralização; regionalização; hierarquização; participação; conjugação de recursos; capacidade resolutiva; organização dos serviços
Organização	Art. 8-10	Organização em distritos sanitários; consórcios administrativos intermunicipais; princípio da municipalização
Direção do SUS	Art. 16-19	Ministério da Saúde (nacional); Secretarias Estaduais (estadual); Secretarias Municipais (municipal)
Competências MS	Art. 16	Formular política nacional; participar da formulação dos planos; definir e coordenar políticas de saúde mental, hanseníase, tuberculose, DST, AIDS; normas e padrões
Financiamento	Art. 31-34	Orçamentos da União, Estados, DF e Municípios; contribuições sociais; receitas próprias das instituições públicas

■ **Atenção — Acréscimo Art. 3 pela Lei 12.864/2013**

→ A prática de atividade física foi incluída como fator determinante e condicionante da saúde

→ Banca frequentemente cita "a Lei 8.080 em sua redação original" — fique atento ao acréscimo de 2013

Princípio	Definição
Universalidade	Garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão
Integralidade	Assistência ao indivíduo de forma integral, com ações de promoção, proteção e recuperação
Equidade	Priorizar quem mais precisa, reduzindo desigualdades; tratar desigualmente os desiguais
Descentralização	Redistribuição de poder e recursos entre esferas de governo
Regionalização	Organização dos serviços segundo regiões de saúde
Hierarquização	Organização dos serviços em níveis de complexidade crescente
Participação	Participação da comunidade (controle social)
Conjugação de Recursos	União de recursos das três esferas de governo
Capacidade Resolutiva	Serviços em todos os níveis de atenção devem ser capazes de resolver os problemas de saúde da população
Organização	Organização dos serviços públicos de saúde

3. LEI 8.142/1990 — PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Instância	Composição	Reunião/Quórum	Função Principal
Conferência de Saúde	Representantes do governo, prestadores, profissionais e usuários (paritária: 50% usuários)	A cada 4 anos (ou extraordinária)	Avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde
Conselho de Saúde	50% usuários, 25% trabalhadores, 25% governo+prestadores	Reunião mensal (mínimo)	Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução; caráter permanente e deliberativo

■ Pegadinha — Conselho vs Conferência

- Conselho: caráter PERMANENTE e DELIBERATIVO (decide, não apenas recomenda)
- Conferência: a cada 4 anos (não é permanente)
- Composição do Conselho: 50% usuários (não profissionais)
- Resolução do Conselho precisa ser HOMOLOGADA pelo chefe do poder executivo correspondente

Tema	Dispositivo
Transferências Regulares	Municípios e Estados que não constituírem Fundos de Saúde, Conselhos e Planos perdem o direito ao repasse regular
Fundo de Saúde	Conta especial; movimentada sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde
Plano de Saúde	Base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS; em sua elaboração consideradas as deliberações da Conferência de Saúde
Relatório de Gestão	Instrumento de controle; apresentado ao Conselho de Saúde ao final de cada exercício

4. DECRETO 7.508/2011 — REGULAMENTAÇÃO DA LEI 8.080

Conceito	Definição
Região de Saúde	Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP)	Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — referência para padronização da prescrição
RENASES	Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde — define o conjunto de ações e serviços que o SUS oferece
Portas de Entrada	APS, atenção de urgência, atenção psicossocial e especial de acesso aberto; acesso ao SUS dá-se preferencialmente pela APS
Mapa da Saúde	Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada

■ **Atenção — Portas de Entrada SUS (Decreto 7.508)**

- APS é a PREFERENCIAL (não obrigatória para urgência/emergência)
- São quatro portas: APS · Urgência · Atenção Psicossocial · Especial de acesso aberto
- Serviços de apoio diagnóstico NÃO são portas de entrada

5. LC 141/2012 — FINANCIAMENTO DO SUS

Esfera	Percentual Mínimo	Base de Cálculo
União	Valor apurado no ano anterior + variação nominal do PIB (EC 86); com EC 95/2016 (Teto de Gastos): reajuste pelo IPCA	Receita corrente líquida → substituída por regra de teto de gastos
Estados	12% das receitas próprias	Arrecadação de impostos estaduais (inclui transferências constitucionais)
Municípios	15% das receitas próprias	Arrecadação de impostos municipais (inclui transferências constitucionais)
DF	12% e 15% (acumula)	Obrigações estaduais + municipais

■ Pegadinha — Percentuais de Financiamento

- Estado: 12%; Município: 15% (lembrar: M de Municipal = mais = 15)
- Emenda Constitucional 29/2000: primeira norma a exigir percentuais mínimos
- LC 141/2012: regulamentou definitivamente os mínimos da EC 29
- EC 95/2016 (Teto de Gastos): congelou por 20 anos os gastos federais (reajuste pelo IPCA)
- O que NÃO conta como gasto em saúde: saneamento, merenda escolar, assistência social

Transferência	Modalidade	Descrição
Fundo a Fundo	Regular e automática	Do Fundo Nacional para Fundos Estaduais e Municipais, sem convênio prévio
Convênios	Específica	Para programas e projetos específicos; exige prestação de contas detalhada
PAB Fixo	Per capita	Valor por habitante para custeio da APS; transferido mensalmente
PAB Variável	Por adesão a programas	ESF, ACS, CEO, NASF — transferido conforme implantação

6. PNAB 2017 — POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Tema	Conteúdo
Conceito APS/AB	Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde
Fundamentos	Territorialização; adscrição de clientela; continuidade do cuidado; coordenação do cuidado; longitudinalidade; integralidade; humanização; equidade; participação social
ESF	Estratégia prioritária para expansão e consolidação da APS; equipe mínima: médico, enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e ACS
Equipe mínima ESF	1 médico (MFC ou generalista) + 1 enfermeiro + 1 a 2 técnicos de enfermagem + 4 a 12 ACS
Carga horária	40h semanais para médico e enfermeiro; ACS: 40h; população: até 4.000 pessoas por equipe
NASF-AB	Amplia a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização; equipes com pelo menos 5 profissionais de nível superior; não é porta de entrada
Atribuições ACS	Visita domiciliar $\geq 1 \times / \text{mês}$ por família; cadastrar famílias; orientar; prevenir; acompanhar; articular ações sociais
e-SUS APS	Sistema de informação; prontuário eletrônico; CDS ou PEC; base para financiamento do PAB variável

■ Atenção — PNAB 2017 vs PNAB 2012

- PNAB 2017 extinguiu a obrigatoriedade do NASF como equipe padrão (passou a ser flexível)
- PNAB 2017 criou a possibilidade de eSF com 1 médico para populações menores
- Redução da cobertura mínima de ACS: não mais obrigatório 100% do território
- Banca ainda usa conceitos da PNAB 2012 — atenção ao enunciado

Atributo (Starfield)	Definição Resumida
Acesso de primeiro contato	Porta de entrada preferencial; acessibilidade e uso a cada problema ou novo episódio
Longitudinalidade	Vínculo continuado ao longo do tempo; responsabilização pela saúde das pessoas
Integralidade	Atenção a todas as necessidades de saúde; encaminhamento quando necessário
Coordenação do cuidado	Articulação entre os diferentes níveis; garantia da continuidade
Focalização na família	Família como unidade de cuidado; contexto familiar considerado
Orientação comunitária	Conhecimento das necessidades da comunidade; participação social
Competência cultural	Respeito à diversidade cultural; adequação do cuidado à realidade local

7. FINANCIAMENTO SUS — EC 29, EC 86, EC 95, LC 141

Norma	Ano	Principal Mudança
EC 29/2000	2000	Primeira emenda a exigir percentuais mínimos de gasto em saúde para todas as esferas; regulamentada pela LC 141/2012
LC 141/2012	2012	Definiu critérios e base de cálculo dos gastos mínimos; definiu o que conta e o que não conta como despesa em saúde
EC 86/2015	2015	Alterou o critério federal para percentual gradativo da Receita Corrente Líquida (chegando a 15% da RCL em 2020)
EC 95/2016	2016	Teto dos gastos públicos federais por 20 anos (até 2036); reajuste apenas pelo IPCA; afeta investimentos em saúde

O que CONTA como despesa em saúde	O que NÃO conta como despesa em saúde
Ações e serviços de saúde (assistência, vigilância, promoção)	Saneamento básico (exceto controlado pelo MS)
Remuneração dos profissionais de saúde em atividade no setor	Merenda escolar
Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde	Assistência social
Produção, aquisição e distribuição de insumos para saúde	Pagamento de aposentadorias e pensões de profissionais de saúde
Vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental	Limpeza urbana e remoção de resíduos

8. RAS — REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (Portaria 4.279/2010)

As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas e missões, integrados através de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscando garantir a integralidade do cuidado.

Componente RAS	Descrição
Centro de Comunicação	APS é o centro de comunicação (não a ponta) — coordena e filtra o fluxo assistencial
Pontos de Atenção	APS, Ambulatório Especializado, Urgência/Emergência, Hospitalar, Domiciliar
Sistemas Logísticos	Cartão SUS, prontuário eletrônico, centrais de regulação, transporte sanitário
Sistemas de Governança	Modelo de atenção, financiamento, gestão, organização, informação, trabalho e educação permanente
Modelo de Atenção	Crônicas: Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC); Agudas: RUE (Rede de Urgência e Emergência)

Rede Temática	Portaria/Decreto	Foco
Rede Cegonha	GM/MS 1.459/2011	Atenção ao pré-natal, parto, puerpério e criança até 24 meses
RUE — Rede Urgência e Emergência	GM/MS 1.600/2011	SAMU, UPA 24h, sala de estabilização, UBS com atenção às urgências, hospitais
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)	GM/MS 3.088/2011	CAPS, UBS, SAMU, leitos, hospitais gerais, consultório na rua
Rede de Atenção à Saúde Bucal	GM/MS 874/2013	CEO, LRPD, Equipes de Saúde Bucal, USF
Rede de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência	GM/MS 793/2012	CER, CPOD, Oficinas Ortopédicas

9. PROMOÇÃO DA SAÚDE — OTTAWA E PNPS 2014

Carta de Ottawa (1986) — Cinco Eixos	Descrição
Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis	Saúde na pauta política; legislação protetora
Criação de ambientes favoráveis à saúde	Ambiente físico e social como suporte à saúde
Reforço da ação comunitária	Empoderamento das comunidades
Desenvolvimento de habilidades pessoais	Educação para a saúde; habilidades para a vida
Reorientação dos serviços de saúde	Serviços além da cura; responsabilidade compartilhada

PNPS 2014 — Temas Prioritários	Estratégia
Formação e Educação Permanente	Capacitação contínua dos profissionais de saúde
Alimentação Adequada e Saudável	PNAE, rotulagem, regulação de alimentos ultraprocessados
Práticas Corporais e Atividade Física	NASF, academia da saúde, PNUD
Enfrentamento do Tabagismo	INCA, abordagem na APS, lei antitabaco
Enfrentamento do Álcool e outras Drogas	CAPS AD, políticas intersetoriais
Mobilidade Urbana e Trânsito	Acidentes como problema de saúde pública
Paz, Violência e Cultura da Paz	Prevenção da violência; cultura de paz
Ambientes e Trabalho Saudáveis	RENAST, saúde do trabalhador integrada à APS

10. DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (DSS)

Modelo/Autor	Descrição
Dahlgren e Whitehead (1991)	Modelo "arco-íris": camadas dos determinantes — estilo de vida individual; redes sociais e comunitárias; condições de vida e trabalho; condições socioeconômicas, culturais e ambientais
CSDH/OMS — Comissão Marmot	Determinantes estruturais (posição social, raça, gênero, renda, educação) geram determinantes intermediários (condições materiais, comportamentos, fatores psicossociais)
CNDSS Brasil (2008)	Comissão Nacional sobre DSS — propôs três eixos: eixo iniquidades, eixo determinação e eixo intervenção

Tipo de Iniquidade	Definição
Iniquidades de saúde	Diferenças evitáveis, injustas e desnecessárias nas condições de saúde entre grupos populacionais
Equidade horizontal	Igual tratamento para necessidades iguais
Equidade vertical	Tratamento diferenciado para necessidades diferentes (priorizar quem mais precisa)

■ Atenção — DSS vs Fatores de Risco

- DSS = condições em que as pessoas NASCEM, CRESCEM, VIVEM, TRABALHAM e ENVELHECEM
- Diferente de fatores de risco individuais (tabagismo, sedentarismo)
- Banca confunde os dois — DSS é o contexto estrutural e social

11. TERRITORIALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Conceito	Definição/Aplicação
Território	Espaço geográfico e social delimitado; não apenas limite geográfico mas dinâmica social, cultural e epidemiológica
Microárea	Subdivisão do território da equipe; responsabilidade do ACS (mínimo 400, máximo 750 pessoas)
Área de abrangência ESF	Até 4.000 pessoas por equipe (ideal 2.000 a 3.500); em áreas de alta vulnerabilidade: mínimo 400/ACS
Diagnóstico Situacional	Levantamento das condições de saúde, estrutura da UBS, perfil epidemiológico; base para o planejamento em saúde local
Mapa de vulnerabilidade	Instrumento de visualização das necessidades do território; orienta as visitas domiciliares prioritárias

Ferramenta	Uso na Territorialização
Cadastro familiar (e-SUS)	Levantamento de características socioeconômicas, sanitárias e de saúde de cada família
Ficha A (antigo sistema)	Ficha de cadastro domiciliar — substituída pelo CDS/PEC no e-SUS
Ficha de Visita Domiciliar	Registro das atividades do ACS por família
SIAB/SISAB	Sistema de Informação da Atenção Básica — alimentado pelos dados do e-SUS

12. VIGILÂNCIA EM SAÚDE — EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo	Base Legal	Função Principal	Exemplos de Ações
Vigilância Epidemiológica	Lei 6.259/1975; Lei 8.080/1990 Art. 6	Monitorar a ocorrência de doenças e agravos; prevenir e controlar epidemias	SINAN; SINASC; SIM; investigação de surtos; notificação compulsória
Vigilância Sanitária (VISA)	Lei 9.782/1999 (ANVISA)	Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde relacionados a produtos e serviços	Fiscalização de alimentos, medicamentos, cosméticos, estabelecimentos de saúde
Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT)	Lei 8.080 Art. 6; Decreto 7.602/2011	Promover e proteger a saúde dos trabalhadores; RENAST	Diagnóstico de LER/DORT, silicose, câncer ocupacional
Vigilância Ambiental	SINVSA; PNVS	Identificar fatores do ambiente que interferem na saúde	Água para consumo humano, ar, solo, vetores, desastres naturais
Vigilância Nutricional	SISVAN; PNAN	Monitorar estado nutricional da população	Anemia, desnutrição, obesidade, consumo alimentar

Sistema de Informação	Sigla	O que registra
Sistema de Informação de Agravos de Notificação	SINAN	Doenças de notificação compulsória; fichas de investigação epidemiológica
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos	SINASC	Declarações de nascidos vivos; dados materno-infantis
Sistema de Informações sobre Mortalidade	SIM	Declarações de óbito; causa básica de morte; mortalidade proporcional
Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional	SISVAN	Estado nutricional de crianças, gestantes, adolescentes, adultos e idosos
Sistema de Informação da Atenção Básica	SISAB/e-SUS	Produção das equipes de APS; indicadores do PMAQ/Previne Brasil

■ Pegadinhas — Vigilância

- VISA (Vigilância Sanitária) ≠ Vigilância Epidemiológica — são sistemas diferentes
- A ANVISA foi criada pela Lei 9.782/1999 — não é uma lei orgânica do SUS
- O SINAN registra AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO — não todos os atendimentos
- O SIM usa a Declaração de Óbito (DO) — preenchida pelo médico

13. LNDC — LEI 13.979/2020 E EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

Tema	Conteúdo
Lei 13.979/2020	Dispõe sobre medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional; disciplina: isolamento, quarentena, exames, vacinação compulsória
Isolamento	Separação de pessoas doentes ou contaminadas; duração mínima necessária para eliminação do risco
Quarentena	Restrição de atividades de pessoas que possam ter sido expostas, mas não apresentam sintomas
Vacinação Compulsória	Poderá ser determinada por autoridade sanitária — exceção ao princípio da autonomia
ESPIN	Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional; declarada pelo Ministério da Saúde
PHEIC/ESPII	Public Health Emergency of International Concern; declarada pela OMS
RSI	Regulamento Sanitário Internacional (2005) — instrumento da OMS para governança de emergências globais
Notificação Compulsória	Lista nacional de DANT (Doenças e Agravos de Notificação) atualizada pela ANVISA/SVS; inclui agravos de notificação imediata e semanal

■ **Atenção — Quarentena vs Isolamento**

- Isolamento: pessoa DOENTE ou CONTAMINADA (confirmada)
- Quarentena: pessoa EXPOSTA mas ainda sem sintomas (suspeita)
- Banca troca os dois — lembre pelo contexto clínico

14. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIS)

SIS	Gestão	Indicadores Gerados
SINAN	SVS/MS	Taxa de incidência, prevalência, mortalidade por doença notificável; oportunidade de investigação
SIM	CGIAE/MS	Taxa de mortalidade geral, infantil, materna; mortalidade proporcional; YPLL
SINASC	CGIAE/MS	Taxa de natalidade; baixo peso ao nascer; APGAR; prematuridade; cobertura de pré-natal
SISVAN	DAB/MS	Prevalência de desnutrição, sobrepeso, obesidade; déficit de crescimento
SISAB/e-SUS	DAB/MS	Cobertura ESF; produção por equipe; indicadores Previne Brasil
SIHSUS	DRAC/MS	Internações hospitalares; AIH; procedimentos realizados; mortalidade hospitalar
SIASUS	DRAC/MS	Procedimentos ambulatoriais do SUS; BPA; APAC
CNES	DRAC/MS	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; leitos; equipamentos; profissionais

■ Macete — Principais SIS para prova

- SIM → óbito → Declaração de Óbito (DO)
- SINASC → nascimento → Declaração de Nascido Vivo (DNV)
- SINAN → agravos notificáveis → Ficha de Notificação/Investigação
- SISAB/e-SUS → produção APS → prontuário eletrônico/CDS

15. PLANEJAMENTO EM SAÚDE — PNS, PMS, PPA, RAG

Instrumento	Esfera	Período	Conteúdo
PPA — Plano Plurianual	Todas	4 anos	Programas e ações governamentais de médio prazo; aprovado pelo Legislativo
PNS — Plano Nacional de Saúde	Federal	4 anos	Objetivos, diretrizes e metas nacionais; elaborado pelo MS; aprovado pelo CNS
PES — Plano Estadual de Saúde	Estadual	4 anos	Traduz o PNS para o contexto estadual; aprovado pelo CES
PMS — Plano Municipal de Saúde	Municipal	4 anos	Traduz o PES para o contexto municipal; aprovado pelo CMS
PAS — Programação Anual de Saúde	Todas	1 ano	Instrumento operativo do Plano de Saúde; detalha metas anuais
RAG — Relatório Anual de Gestão	Todas	1 ano	Presta contas ao Conselho de Saúde; avalia o cumprimento do PAS

■ Pegadinha — Quem aprova o Plano de Saúde?

- O Plano de Saúde é elaborado pelo gestor (Secretaria) e APROVADO pelo Conselho de Saúde correspondente
- O RAG é apresentado ao Conselho de Saúde — não ao Legislativo
- PPA é aprovado pelo Legislativo (Câmara/Assembleia/Congresso)

Método/Ferramenta	Uso no Planejamento em Saúde
SWOT (FOFA)	Análise de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças; diagnóstico estratégico
PES — Planejamento Estratégico Situacional (Matus)	Momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional
Marco Lógico	Estrutura de objetivos, indicadores, meios de verificação e pressupostos
Planilha de Priorização	Método de análise de vulnerabilidade + impacto para priorizar problemas de saúde

16. HUMANIZASUS — POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH 2004)

Princípio PNH	Descrição
Transversalidade	A humanização deve perpassar todas as políticas de saúde — não é programa isolado
Indissociabilidade entre atenção e gestão	Quem cuida precisa ser cuidado; mudar práticas de gestão e atenção juntos
Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos	Usuários, trabalhadores e gestores como coautores do processo de produção de saúde

Dispositivo HumanizaSUS	Onde se aplica	Função
Acolhimento	APS e todos os níveis	Receber, ouvir, responsabilizar-se; não é triagem, mas atitude
Clínica Ampliada	APS e especializada	Ampliar o objeto de trabalho; considerar o sujeito; compartilhar saberes
Projeto Terapêutico Singular (PTS)	Equipe multiprofissional	Conjunto de propostas articuladas para um sujeito específico
Apoio Matricial (Matriciamento)	NASF-AB / CAPS	Suporte técnico e pedagógico de equipes especializadas à APS
Equipe de Referência	Multiprofissional	Responsabiliza-se longitudinalmente pelo usuário
Visita Aberta e Direito a Acompanhante	Hospital	Direito do paciente de ter acompanhante e visitas abertas
Colegiado Gestor	Gestão	Gestão compartilhada; decisões coletivas
Ouvidoria e GTE	Gestão e atenção	Grupo de Trabalho de Humanização; voz do usuário

17. POLÍTICAS ESPECÍFICAS — PNSI, PNSM, PNCD, PNCT, PNAB

Política	Sigla	Foco Principal	Destaques para Prova
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra	PNSIPN (2009)	Equidade racial na saúde; combate ao racismo institucional	Doença falciforme; hipertensão; acesso desigual
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa	PNSPI (2006)	Envelhecimento saudável; funcionalidade; cuidado integral	Avaliação Geriátrica Ampla (AGA); prevenção de quedas
Política Nacional de Saúde Mental	PNSM / Lei 10.216/2001	Reforma Psiquiátrica; desinstitucionalização; RAPS	CAPS como dispositivo central; internação como último recurso
Política Nacional de Controle do Diabetes	PNCD	Rastreamento; tratamento; automonitoramento	Metas glicêmicas; HbA1c; Previne Brasil
Política Nacional de Controle do Tabagismo	PNCT / INCA	Abordagem mínima e intensiva; TRN; vareniclina	5As: Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange
Política Nacional de Alimentação e Nutrição	PNAN 2012	Alimentação adequada e saudável; SISVAN; PNAE	Marco de referência de educação alimentar e nutricional
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares	PNPIC 2006	Acupuntura, plantas medicinais, homeopatia, termalismo, meditação	Ampliada em 2017 e 2018 para 29 práticas

18. PNI — PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Tema	Conteúdo
Base Legal	Lei 6.259/1975; Decreto 78.231/1976; Lei 8.080/1990 (Art. 6 — vigilância epidemiológica e sanitária); Lei 13.979/2020 (vacinação compulsória em emergência)
Criação do PNI	1973 — antes da CF/88 e do SUS; Calendário Nacional de Vacinação atualizado anualmente pelo MS
Calendário Atual	Criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, indígena, trabalhadores de saúde; disponível no site do MS/CONASS
Vacinação Compulsória	Crianças: obrigatória por lei (sanção: matrícula escolar negada); adultos: obrigatória em emergência epidemiológica
Salas de Vacina	Estrutura mínima: geladeira exclusiva, termômetro, caderneta, EPI; rede de frio rigorosa
Rede de Frio	Temperatura de conservação: +2°C a +8°C (maioria); algumas vacinas NÃO podem ser congeladas (ex: hepatite B, dupla adulto, anti-rábica)
VIP vs VOP	VIP (inativada): substituiu VOP para crianças em 2016 (esquema 3 doses + reforços); VOP (oral) mantida em campanha
BCG	Ao nascer (maternidade); dose única; contraindicada em imunodeprimidos graves
Tríplice Viral (SCR)	2 doses; a 1ª aos 12 meses e 2ª aos 15 meses (junto à tetra viral/SCR + Varicela)

■ Pegadinha — PNI e Vacinação

- VOP ("Sabin") está sendo substituída pela VIP ("Salk") no esquema básico — mas VOP ainda é usada em campanhas
- BCG: contraindicada para imunodeprimidos (HIV com CD4 <200, corticoterapia imunossupressora)
- Vacina da Influenza: anual; reformulada; grávidas, idosos, profissionais de saúde têm prioridade
- Hepatite B: 3 doses (0, 1, 6 meses); conservar em +2°C a +8°C; NÃO congelar

19. MACETES E PEGADINHAS — SUS

■ **Macete — As 3 Leis Fundamentais do SUS**

- CF/88 Arts. 196-200: base constitucional
- Lei 8.080/1990: organização, princípios, diretrizes do SUS
- Lei 8.142/1990: controle social (conselhos e conferências)
- Decreto 7.508/2011: regulamenta a Lei 8.080 (COAP, RENASES, RENAME, portas de entrada)

■ **Macete — Princípios Doutrinários vs Organizativos**

- DOUTRINÁRIOS (UV Integral): Universalidade · eqUidade · Integralidade
- ORGANIZATIVOS: Descentralização · Regionalização · Hierarquização · Participação
- Banca chama de "diretrizes" a descentralização, integralidade e participação (Art. 198 CF/88)

■ **Macete — Conselhos de Saúde (Lei 8.142)**

- 50% USUÁRIOS (maioria) · 25% trabalhadores · 25% governo + prestadores
- PERMANENTE e DELIBERATIVO (não apenas consultivo)
- Resolução: deve ser HOMOLOGADA pelo chefe do executivo
- Reunião: ordinária mensal (mínimo)

■ **Macete — Financiamento (LC 141/2012)**

- Estado: 12% · Município: 15% (M de Municipal = maior = 15)
- EC 29/2000 criou; LC 141/2012 regulamentou
- EC 95/2016: teto de gastos por 20 anos → reajuste pelo IPCA
- Não conta: saneamento, merenda, assistência social, aposentadorias

■ **Macete — RENASES vs RENAME**

- RENASES = Relação de AÇÕES E SERVIÇOS (o que o SUS oferece)
- RENAME = Relação de MEDICAMENTOS Essenciais (o que o SUS dispensa)
- Ambas definidas no Decreto 7.508/2011

■ **Macete — Sistemas de Informação**

- SIM → óbito (Declaração de Óbito)
- SINASC → nascimento (Declaração de Nascido Vivo)
- SINAN → agravos notificáveis (Ficha de Notificação)
- SISAB/e-SUS → produção APS
- CNES → cadastro de estabelecimentos e profissionais

■ **Macete — Ottawa (1986): 5 Eixos**

- 1. Políticas públicas saudáveis
- 2. Ambientes favoráveis
- 3. Ação comunitária
- 4. Habilidades pessoais
- 5. Reorientação dos serviços
- Lembrar: "PA ACH RE" → Políticas · Ambientes · Ação · Competências · Habilidades · Reorientação

■ **Macete — HumanizaSUS (PNH 2004)**

- 3 princípios: Transversalidade · Indissociabilidade atenção/gestão · Protagonismo/autonomia
- Acolhimento ≠ triagem: é atitude, não procedimento
- Apoio Matricial = matriciamento = NASF apoia ESF
- PTS = Projeto Terapêutico Singular (para casos complexos)

1. Saúde como DIREITO e DEVER

→ A CF/88 diz que a saúde é direito de TODOS e dever do ESTADO (não apenas do governo federal). Banca frequentemente troca "dever do Estado" por "dever da União" — errado.

2. Setor Privado no SUS

→ A participação da iniciativa privada no SUS é COMPLEMENTAR e LIVRE — não é proibida. O que é vedado: destinar recursos públicos para entidades LUCRATIVAS (Art. 199, §2º, CF/88).

3. Conferência de Saúde — periodicidade

→ A cada 4 ANOS (não a cada 2). Pode ser convocada extraordinariamente. Não é permanente (ao contrário do Conselho de Saúde, que é permanente e deliberativo).

4. Conselho de Saúde — composição

→ 50% USUÁRIOS (não profissionais, não gestores). Os outros 50%: 25% trabalhadores de saúde + 25% governo e prestadores de serviços.

5. Art. 3 da Lei 8.080 — acréscimo

→ A prática de ATIVIDADE FÍSICA foi incluída nos fatores determinantes pela Lei 12.864/2013. O texto original de 1990 não incluía atividade física.

6. Portas de entrada do SUS (Decreto 7.508)

→ São 4 portas: APS · Urgência · Atenção Psicossocial · Especial de acesso aberto. Serviços de apoio diagnóstico (laboratório, imagem) NÃO são portas de entrada.

7. COAP — o que é

→ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Acordo entre ENTES FEDERATIVOS (não entre prestadores e gestor). Instrumento do Decreto 7.508.

8. EC 29/2000 vs LC 141/2012

→ EC 29 de 2000 CRIOU a obrigação dos percentuais mínimos. LC 141/2012 REGULAMENTOU e definiu os critérios detalhados. Banca testa a ordem cronológica.

9. Percentuais: Estado 12%, Município 15%

→ ESTADO: mínimo 12%. MUNICÍPIO: mínimo 15%. "M de Municipal = maior = 15%." DF aplica as duas obrigações simultaneamente.

10. O que NÃO é gasto em saúde (LC 141)

→ Saneamento básico, merenda escolar, assistência social e pagamento de aposentadorias de ex-profissionais de saúde NÃO contam como despesa em saúde para fins da LC 141.

11. NASF — porta de entrada?

→ NASF-AB NÃO é porta de entrada do SUS. Apoia as equipes de APS por meio do matriciamento. Não faz atendimento direto sem referência da ESF.

12. ACS — vínculo empregatício

→ O ACS deve residir na comunidade onde trabalha. Deve realizar ≥1 visita domiciliar por mês por família. NÃO precisa ser de nível superior (ensino médio é suficiente).

13. Acolhimento ≠ triagem

→ Acolhimento (HumanizaSUS/PNH) NÃO é triagem por ordem de chegada. É reconhecer as necessidades do usuário e responsabilizar-se. Pode ser feito por qualquer profissional de saúde.

14. Apoio Matricial vs Referência e Contrarreferência

→ Matriciamento = equipe especializada APOIA a APS sem substituir. Referência = encaminhamento para nível mais complexo. Contrarreferência = retorno ao nível anterior com relatório.

15. Lei 10.216/2001 — Reforma Psiquiátrica

→ Redireciona o modelo assistencial; prioriza tratamento em liberdade. A internação psiquiátrica deve ser ÚLTIMO RECURSO. CAPS é o dispositivo central da RAPS — não o hospital psiquiátrico.

16. PNI — VOP substituída pela VIP

→ Desde 2016, a VOP (oral, "Sabin") foi substituída pela VIP (inativada, "Salk") no esquema básico de criança. VOP ainda é usada em campanhas nacionais.

17. Quarentena vs Isolamento (Lei 13.979/2020)

→ Isolamento: para pessoa DOENTE/confirmada. Quarentena: para pessoa EXPOSTA mas sem sintomas. Banca frequentemente inverte os conceitos.

18. SIM vs SINASC vs SINAN

→ SIM → MORTALIDADE (Declaração de Óbito). SINASC → NASCIMENTOS (Declaração de Nascido Vivo). SINAN → AGRAVOS NOTIFICÁVEIS (Ficha de Notificação). Não confundir.

19. RAG — quem apresenta e a quem

→ O Relatório Anual de Gestão é apresentado pelo GESTOR ao CONSELHO DE SAÚDE (não ao Legislativo, não à Conferência). Prazo: ao final de cada exercício.

20. Plano de Saúde — quem aprova

→ O Plano de Saúde (PNS/PES/PMS) é elaborado pela Secretaria/Ministério e APROVADO pelo respectivo Conselho de Saúde. NÃO é aprovado pelo Legislativo (diferente do PPA).

21. Equidade ≠ Igualdade

→ Igualdade: tratar todos da mesma forma. Equidade: tratar desigualmente os desiguais — priorizar quem mais precisa. O SUS adota o princípio da EQUIDADE, não da igualdade pura.

22. PNAB 2017 — NASF não é obrigatório

→ A PNAB 2017 tornou o NASF OPCIONAL (não obrigatório). A PNAB 2012 exigia mínimo de profissionais. Banca usa enunciados sobre "equipe mínima da ESF" — NASF não integra a equipe mínima.

23. Carta de Ottawa — local e ano

→ Ottawa, CANADÁ, 1986. Não confundir com Alma-Ata (URSS, 1978) — que propôs "Saúde para todos até o ano 2000" e os Cuidados Primários de Saúde (CPS).

24. Territorialização — número de famílias por ACS

→ Cada ACS é responsável por 400 a 750 pessoas (não famílias). Equipe ESF: até 4.000 pessoas (ideal 2.000-3.500). Em área de alta vulnerabilidade: o mínimo por ACS pode ser 400 pessoas.

25. Fundo de Saúde — quem fiscaliza

→ O Fundo de Saúde é uma conta especial. A movimentação é feita pelo gestor, MAS sob fiscalização do CONSELHO DE SAÚDE. Não é fiscalizado pela Receita Federal diretamente.

20. QUESTÕES DE REVISÃO — SUS

Q1: Segundo a CF/88 (Art. 198), são diretrizes do SUS, EXCETO:

- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- B) Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas
- C) Participação da comunidade
- D) Universalidade de acesso em todos os níveis de assistência
- E) Descentralização e regionalização dos serviços

■ **Gabarito: D**

As diretrizes do Art. 198 são: descentralização, atendimento integral e participação. Universalidade é princípio doutrinário (Art. 7, Lei 8.080), não diretriz constitucional do Art. 198.

Q2: A Lei 8.142/1990 estabelece que os Conselhos de Saúde têm caráter:

- A) Consultivo e temporário
- B) Deliberativo e permanente
- C) Fiscalizador e consultivo
- D) Normativo e provisório
- E) Legislativo e permanente

■ **Gabarito: B**

Os Conselhos de Saúde são PERMANENTES e DELIBERATIVOS (tomam decisões vinculantes, não apenas recomendam). As resoluções devem ser homologadas pelo chefe do executivo.

Q3: De acordo com a LC 141/2012, o percentual mínimo de aplicação em ações e serviços de saúde pelos Municípios é de:

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 18%
- E) 20%

■ **Gabarito: C**

Municípios: 15%. Estados: 12%. "M de Municipal = Maior = 15%." União: segue regra da EC 86/95 (percentual da RCL ou teto pelo IPCA).

Q4: O Decreto 7.508/2011 define como PORTAS DE ENTRADA preferencial do SUS:

- A) A Atenção Primária à Saúde (APS)
- B) Os serviços de urgência e emergência
- C) Os ambulatorios de especialidades
- D) Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
- E) Os hospitais de alta complexidade

■ **Gabarito: A**

A APS é a PORTA PREFERENCIAL. As 4 portas são: APS, urgência, atenção psicossocial e especial de acesso aberto. Apoio diagnóstico NÃO é porta de entrada.

Q5: Sobre o NASF-AB, segundo a PNAB 2017, é CORRETO afirmar:

- A) É porta de entrada obrigatória do SUS
- B) Integra a equipe mínima da Estratégia Saúde da Família
- C) Amplia a resolutividade das equipes de APS por meio do apoio matricial
- D) Realiza atendimentos diretos sem necessidade de encaminhamento pela ESF
- E) É obrigatório em todos os municípios com ESF implantada

■ **Gabarito: C**

NASF-AB faz apoio matricial (matriciamento) às equipes de APS — não é porta de entrada, não é obrigatório e não integra a equipe mínima da ESF.

Q6: Qual dos seguintes NÃO é considerado gasto em saúde para fins da LC 141/2012?

- A) Remuneração dos profissionais de saúde da rede pública
- B) Aquisição de medicamentos para a rede hospitalar
- C) Programas de saneamento básico municipal
- D) Ações de vigilância epidemiológica
- E) Campanhas de vacinação

■ **Gabarito: C**

Saneamento básico NÃO conta como despesa em saúde para fins dos mínimos constitucionais. Também não contam: merenda escolar, assistência social, aposentadorias de ex-profissionais.

Q7: A Carta de Ottawa (1986) identifica cinco campos de ação para a promoção da saúde. NÃO é um desses campos:

- A) Criação de ambientes favoráveis à saúde
- B) Reforço da ação comunitária
- C) Reorientação dos serviços de saúde
- D) Controle de doenças crônicas não transmissíveis
- E) Elaboração de políticas públicas saudáveis

■ **Gabarito: D**

Os 5 campos da Carta de Ottawa são: políticas saudáveis, ambientes favoráveis, ação comunitária, habilidades pessoais e reorientação dos serviços. "Controle de DCNT" não é um dos campos originais.

Q8: Segundo a Lei 13.979/2020, a medida que restringe atividades de pessoas EXPOSTAS mas assintomáticas é denominada:

- A) Isolamento
- B) Quarentena
- C) Internação compulsória
- D) Vigilância sanitária
- E) Notificação compulsória

■ **Gabarito: B**

Quarentena: pessoas EXPOSTAS (assintomáticas). Isolamento: pessoas DOENTES/contaminadas. Esta inversão é a pegadinha mais clássica do tema.

Q9: Em relação à composição dos Conselhos de Saúde, é CORRETO afirmar que:

- A) 50% são trabalhadores de saúde e 50% são usuários
- B) 25% são usuários, 25% são trabalhadores e 50% são gestores
- C) 50% são usuários, 25% são trabalhadores e 25% são governo e prestadores
- D) 33% são usuários, 33% trabalhadores e 33% governo
- E) A composição varia conforme legislação estadual ou municipal

■ **Gabarito: C**

50% USUÁRIOS + 25% trabalhadores + 25% governo/prestadores. Isso garante a maioria dos usuários (paridade usuários vs restante).

Q10: O Sistema de Informação que registra a MORTALIDADE da população brasileira, por meio da Declaração de Óbito, é:

- A) SINAN
- B) SINASC
- C) SIM
- D) SISAB
- E) CNES

■ **Gabarito: C**

SIM = Sistema de Informações sobre Mortalidade → Declaração de Óbito (DO). SINASC → nascimentos (DNV). SINAN → agravos notificáveis.

Q11: Sobre o Apoio Matricial (Matriciamento), é CORRETO que:

- A) Substitui o atendimento das equipes de APS por profissionais especializados
- B) É realizado exclusivamente por médicos especialistas
- C) Consiste no suporte técnico e pedagógico de equipes especializadas às equipes de APS
- D) Requer encaminhamento formal (referência) para cada caso
- E) É sinônimo de referência e contrarreferência

■ **Gabarito: C**

Matriciamento = apoio técnico-pedagógico, não substituição. O NASF-AB realiza apoio matricial. A ESF mantém a responsabilidade pelo cuidado.

Q12: Qual instrumento do planejamento em saúde detalha as metas ANUAIS e operacionaliza o Plano de Saúde?

- A) Relatório Anual de Gestão (RAG)
- B) Programação Anual de Saúde (PAS)
- C) Plano Plurianual (PPA)
- D) Plano Nacional de Saúde (PNS)
- E) Plano Municipal de Saúde (PMS)

■ **Gabarito: B**

PAS = Programação Anual de Saúde → instrumento operativo ANUAL do Plano de Saúde. RAG = presta contas do cumprimento do PAS ao final do exercício.

Q13: A Política Nacional de Humanização (PNH/HumanizaSUS) tem como princípio fundante:

- A) A hierarquização dos serviços de saúde
- B) A transversalidade, perpassando todas as políticas de saúde
- C) A especialização do cuidado por níveis de atenção
- D) A regionalização como eixo central de reorganização
- E) A informatização dos prontuários como ferramenta de humanização

■ **Gabarito: B**

TRANSVERSALIDADE é o princípio fundante da PNH: a humanização deve perpassar todas as políticas de saúde, não ser um programa isolado.

Q14: O COAP (Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde) é definido pelo Decreto 7.508/2011 como um acordo firmado entre:

- A) Prestadores privados e gestores municipais
- B) Entes federativos (União, Estados, DF e Municípios)
- C) Hospitais públicos e Secretarias de Saúde
- D) Conselhos de Saúde e Ministério da Saúde
- E) Fundações públicas e autarquias de saúde

■ **Gabarito: B**

COAP é acordo entre ENTES FEDERATIVOS para organizar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada. Não é contrato com prestadores privados.

Q15: Segundo a PNAB 2017, o número máximo de pessoas por equipe de Saúde da Família é:

- A) 2.000
- B) 3.000
- C) 3.500
- D) 4.000
- E) 5.000

■ **Gabarito: D**

Máximo: 4.000 pessoas por equipe ESF. Ideal: 2.000 a 3.500. Em área de alta vulnerabilidade: mínimo pode ser 400 pessoas por ACS.

Q16: A Emenda Constitucional 29/2000 teve sua regulamentação complementada pela:

- A) Lei 9.782/1999 (ANVISA)
- B) Lei 8.142/1990
- C) Lei Complementar 141/2012
- D) Decreto 7.508/2011
- E) EC 95/2016

■ **Gabarito: C**

EC 29/2000 CRIOU os percentuais mínimos. LC 141/2012 os REGULAMEN TOU em detalhes (base de cálculo, o que conta e não conta como gasto em saúde).

Q17: Na Rede de Atenção à Saúde (RAS), a APS é descrita como:

- A) Ponta da rede assistencial
- B) Centro de comunicação da rede
- C) Nível de maior densidade tecnológica
- D) Porta de saída do sistema
- E) Nível exclusivo de urgência e emergência

■ **Gabarito: B**

APS é o CENTRO DE COMUNICAÇÃO da RAS (não a ponta). Ela coordena e filtra o fluxo assistencial para os demais pontos da rede.

Q18: Qual das seguintes afirmativas sobre a Lei 8.080/1990 está INCORRETA?

- A) Define os princípios e diretrizes do SUS
- B) Inclui a atividade física como fator determinante da saúde desde 1990
- C) Prevê a vigilância sanitária e epidemiológica como atribuições do SUS
- D) Estabelece que a direção do SUS é única em cada esfera de governo
- E) Define os objetivos do SUS, incluindo a assistência às pessoas

■ **Gabarito: B**

INCORRETA: A atividade física foi incluída como fator determinante pela Lei 12.864/2013, não desde 1990. A Lei 8.080 original não previa atividade física no Art. 3.

21. CHECKLIST FINAL DE REVISÃO — SUS

■ CF/88 — Arts. 196-200

- Art. 196: saúde = direito de TODOS + dever do ESTADO
- Art. 198: diretrizes = descentralização + integralidade + participação
- Art. 199: setor privado = COMPLEMENTAR; vedado recurso público para entidade lucrativa
- Art. 200: atribuições do SUS (8 incisos)

■ Lei 8.080/1990

- Art. 3: fatores determinantes incluem atividade física (acréscimo 2013)
- Art. 7: princípios doutrinários (universalidade, integralidade, equidade) + organizativos
- Art. 16: competências do Ministério da Saúde
- Direção única em cada esfera

■ Lei 8.142/1990

- Conselho de Saúde: permanente, deliberativo, 50% usuários
- Conferência de Saúde: a cada 4 anos
- Transferências condicionadas: Fundo + Conselho + Plano
- RAG apresentado ao Conselho ao final de cada exercício

■ Decreto 7.508/2011

- Região de Saúde: espaço geográfico contínuo
- COAP: acordo entre entes federativos
- RENASES: ações e serviços
- RENAME: medicamentos essenciais
- 4 portas de entrada: APS (preferencial), urgência, psicossocial, especial

■ Financiamento (LC 141/2012)

- Estado: 12%; Município: 15%; DF: ambos
- EC 29/2000 criou; LC 141 regulamentou
- EC 95/2016: teto de gastos 20 anos, reajuste IPCA
- Não conta: saneamento, merenda, assistência social, aposentadorias

■ Promoção da Saúde

- Alma-Ata 1978: cuidados primários, "Saúde para todos até 2000"
- Ottawa 1986: 5 campos de ação (políticas, ambientes, comunidade, habilidades, serviços)
- PNPS 2014: 8 temas prioritários
- DSS: Dahlgren-Whitehead (arco-íris); CSDH/OMS (Marmot)

■ PNAB e Atenção Básica

- ESF: equipe mínima = médico + enfermeiro + técnico + ACS
- Até 4.000 pessoas por equipe; ideal 2.000-3.500
- NASF: apoio matricial, não é porta de entrada, não é obrigatório (PNAB 2017)
- ACS: ≥1 visita/mês por família; mora na comunidade
- Atributos Starfield: 1° contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, família, comunidade, cultura

■ Sistemas de Informação

- SIM → óbito (DO)
- SINASC → nascimento (DNV)
- SINAN → agravos notificáveis (Ficha de Notificação)
- SISAB/e-SUS → produção APS
- CNES → cadastro de estabelecimentos

■ **HumanizaSUS (PNH 2004)**

- 3 princípios: transversalidade, indissociabilidade atenção/gestão, protagonismo
- Acolhimento ≠ triagem; é atitude de qualquer profissional
- Apoio Matricial = NASF apoia ESF sem substituir
- PTS = Projeto Terapêutico Singular

22. COMPLEMENTO — GESTÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA NO SUS

Regulação no SUS

Tipo de Regulação	Conceito	Exemplos
Regulação de Sistemas de Saúde	Controle, avaliação e auditoria; acreditação	DAF, DENASUS, TCU, CGU
Regulação da Atenção à Saúde	Organização e controle da oferta de serviços; acesso	Centrais de regulação, SISREG, TFD
Regulação Assistencial	Ordenação do acesso aos serviços; priorização por risco clínico	CROSS, regulação de leitos, SAMU

Auditoria e Controle no SUS

Instância	Sigla	Função
Departamento Nacional de Auditoria do SUS	DENASUS	Auditoria das ações e serviços de saúde no âmbito federal
Componente Estadual do SNA	CESAS	Auditoria estadual do SUS
Componente Municipal do SNA	CESMU	Auditoria municipal do SUS
Tribunal de Contas da União	TCU	Controle externo dos recursos federais da saúde
Controladoria-Geral da União	CGU	Controle interno do Poder Executivo federal
Ministério Público	MP	Fiscalização do cumprimento da legislação do SUS

Acreditação Hospitalar

Nível	Denominação	Requisitos
Nível 1	Acreditado	Cumprir requisitos básicos de segurança e qualidade assistencial
Nível 2	Acreditado Pleno	Cumprir requisitos + evidências de organização e incorporar gestão
Nível 3	Acreditado com Excelência	Cumprir nível 2 + ciclos de melhoria contínua; benchmarking

■ Macete — DENASUS e Sistema Nacional de Auditoria

→ SNA = Sistema Nacional de Auditoria (Lei 8.080, Art. 17)

→ 3 componentes: DENASUS (federal) + CESAS (estadual) + CESMU (municipal)

→ Auditoria ≠ fiscalização: auditoria avalia a qualidade e eficiência; fiscalização verifica a conformidade legal

Consórcios Públicos de Saúde

Tema	Definição
Base Legal	Lei 11.107/2005; regulamentada pelo Decreto 6.017/2007
Conceito	Pessoas jurídicas formadas exclusivamente por entes da federação para realização de objetivos de interesse comum
Modalidades	Consórcio Público de Direito Público (associação pública) ou Direito Privado
Uso em Saúde	Consórcios intermunicipais de saúde para oferta de serviços especializados, SAMU, diagnóstico por imagem, TFD
Vantagem	Municípios pequenos compartilham serviços que sozinhos não conseguiriam manter